

TEMA 2.19 • GINECOLOGÍA

Prolapso Genital

PERFIL EUNACOM 2.01.1.084

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Prolapso Genital

Causa

Multiparidad (principal) — a mayor número de partos vaginales, mayor riesgo. Las cesáreas también confieren riesgo, pero menor.

Clínica

- Sensación de peso y humedad genital - Tumoración visible en zona genital (prolapso visible) - Puede ulcerarse y sangrar (prolapso avanzado) - **↑ con maniobra de Valsalva** (tos, estornudo, aumento de presión intraabdominal)
Diagnóstico: Clínico. Punto de referencia anatómico: **introito vaginal** (plano del himen).

Clasificación

TABLA 2.19.1: COMPARTIMENTO VS ESTRUCTURA PROLAPSADA			
COMPARTIMENTO	ESTRUCTURA PROLAPSADA	NOMBRE	TRATAMIENTO
Anterior	Vejiga (más frecuente)	Cistocele	Colporrafia anterior (vaginoplastia anterior)
Anterior	Uretra	Uretrocele	Colporrafia anterior
Medio	Útero	Histerocele	Histerectomía + fijación de cúpula vaginal
Posterior	Recto	Rectocele	Colporrafia posterior (vaginoplastia posterior)
Posterior	Asas intestinales	Enteroccele	Colporrafia posterior

PERLA CLÍNICA EUNACOM
Regla: Prolapso anterior o posterior → vaginoplastia (anterior o posterior). Prolapso medio (histerocele) → histerectomía.

Tratamiento

TABLA 2.19.2: SITUACIÓN VS TRATAMIENTO	
SITUACIÓN	TRATAMIENTO
Paciente apta para cirugía	Cirugía según compartimento (ver tabla)
Alto riesgo quirúrgico (anciana, cardiópata, postrada)	Pesario (dispositivo de silicona intravaginal)
Paciente sin actividad sexual futura + alto riesgo quirúrgico	Colpocclisis (cierre quirúrgico de la vagina) — mínimamente invasiva

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN
EUNACOM: Prolapso completo en paciente de alto riesgo (ej. 90+ años, demente, postrada) → conducta es **pesario**, no cirugía.

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:
"Respecto a Prolapso Genital, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para el EUNACOM?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:
Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para Prolapso Genital. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

- PUNTOS CLAVE DESTACADOS
- Clínica
 - Clasificación
 - Tratamiento
 - ↑ con maniobra de Valsalva
 - Clínico. Punto de referencia anatómico:
 - | Vejiga (más frecuente) |
 - + fijación de cúpula vaginal | |

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (PROLAPSO GENITAL)

PREGUNTA 1

Respecto a Prolapso Genital, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA para el EUNACOM?

- A) El diagnóstico de Prolapso Genital se basa exclusivamente en criterios de laboratorio
- B) El manejo inicial de Prolapso Genital debe orientarse según el estado clínico del paciente
- C) Todo paciente con Prolapso Genital requiere hospitalización inmediata
- D) El tratamiento de Prolapso Genital es igual en todas las edades y contextos clínicos
- E) El seguimiento de Prolapso Genital no es necesario una vez iniciado el tratamiento

PREGUNTA 2

¿Cuál es el hallazgo más característico o criterio diagnóstico principal en Prolapso Genital?

- A) Alteración exclusivamente en exámenes de laboratorio sin síntomas
- B) Presentación clínica específica que orienta al diagnóstico según el perfil EUNACOM
- C) Requiere siempre confirmación con biopsia o estudio histológico
- D) Es un diagnóstico de exclusión que requiere descartar todas las otras causas primero
- E) Solo se presenta en pacientes con factores de riesgo conocidos

PREGUNTA 3

Paciente consulta con cuadro compatible con Prolapso Genital. Según el perfil EUNACOM, ¿cuál es la conducta de seguimiento más apropiada?

- A) Alta sin controles dado que es una condición autolimitada
- B) Derivación inmediata al especialista en todos los casos
- C) Control según evolución clínica y criterios del perfil EUNACOM para esta patología
- D) Hospitalización preventiva en todos los casos para monitorización
- E) Tratamiento de por vida sin necesidad de controles periódicos

RESUMEN: PROLAPSO GENITAL

Multiparidad (principal) — a mayor número de partos vaginales, mayor riesgo. Las cesáreas también confieren riesgo, pero menor.
Regla: Prolapso anterior o posterior → vaginoplastia (anterior o posterior). Prolapso medio (histerocele) → histerectomía.
EUNACOM: Prolapso completo en paciente de alto riesgo (ej. 90+ años, demente, postrada) → conducta es pesario, no cirugía.